

45_Intérêt du Ratio TG/HDL-cholestérol comme biomarqueur d'orientation de l'insulinorésistance chez le diabétique de type 2 : à propos de 98 cas au CHU de Constantine

Boukider Nadjat^{1,2,3} ; Tabet Aya^{1,2} ; Boutobba Kawther^{1,2}

¹.Laboratoire de biochimie de CHU Constantine

².Faculté de médecine université de Constantine 3

³.Département de pharmacie de Constantine

Introduction

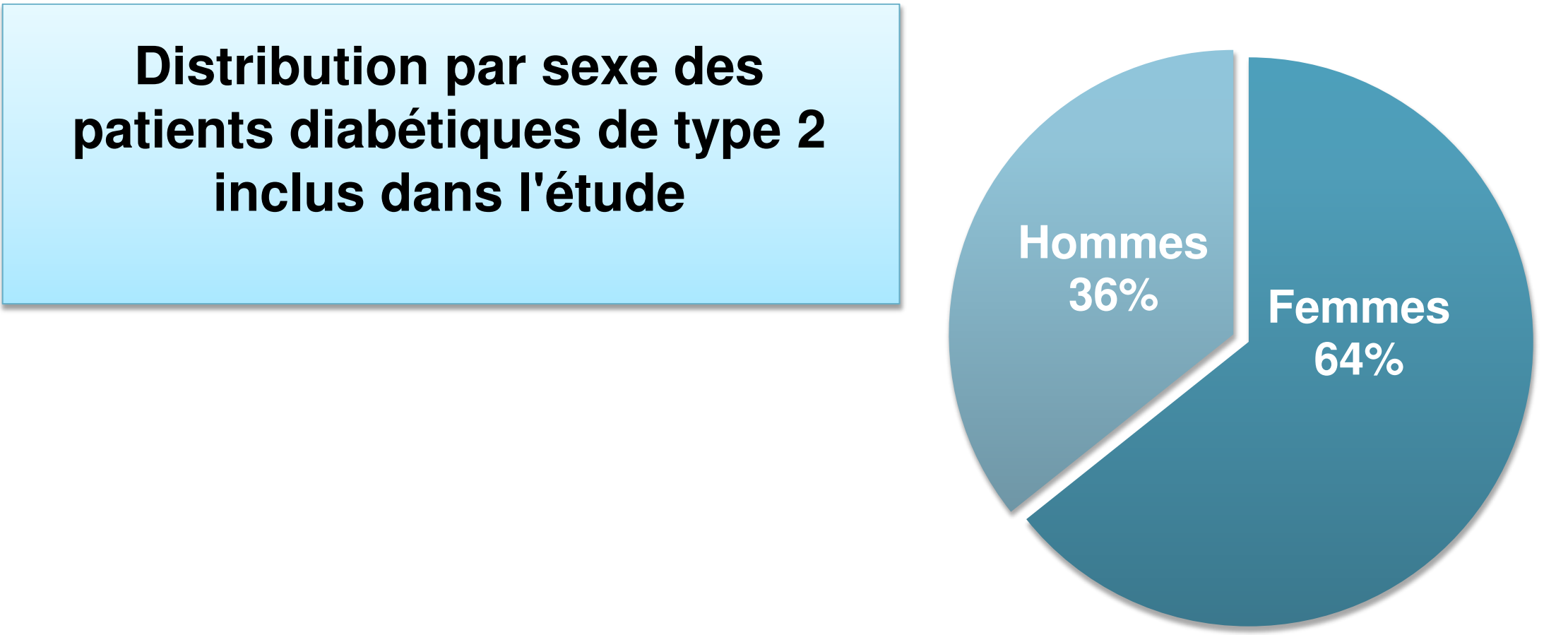
Le diabète de type 2 (DT2) constitue un enjeu majeur de santé publique en raison de sa prévalence croissante à l'échelle mondiale. L'insulinorésistance (IR), principal mécanisme physiopathologique de cette affection, précède souvent de plusieurs années l'apparition de l'hyperglycémie clinique. Les méthodes de référence permettant de l'évaluer, telles que le clamp euglycémique hyperinsulinémique et l'indice HOMA-IR, sont coûteuses, complexes et peu accessibles en pratique courante, notamment dans les pays à ressources limitées. Dans ce contexte, l'identification de biomarqueurs indirects, simples, reproductibles et peu coûteux est essentielle. Le ratio triglycérides/HDL-cholestérol (TG/HDL-c), calculé à partir d'un bilan lipidique standard, apparaît comme un marqueur prometteur pour estimer l'insulinorésistance ;

Objectifs

Évaluer la distribution du ratio TG/HDL-c chez des patients DT2 selon la stratification (risques faible $R < 2$, modéré R entre 2-3 , élevé $R > 3$) afin de proposer son utilisation systématique comme bilan d'orientation accessible avant le recours à des examens de confirmation coûteux

Matériels et méthodes

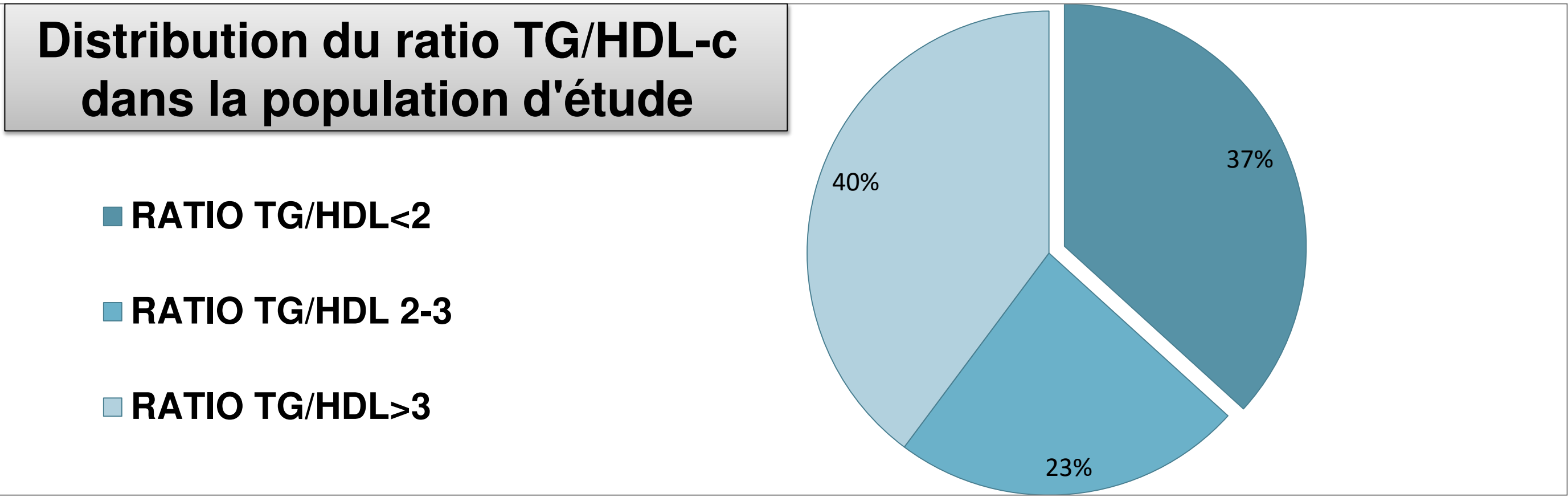
Il s'agit d'une étude descriptive transversale menée sur une période de 3 mois au niveau du service de biochimie du CHU de Constantine (Ibn Badis). L'étude a porté sur un échantillon de 98 patients déjà diagnostiqués atteints de diabète de type 2 (DT2), âgés de 30 à 80 ans, dont 63 femmes et 35 hommes. Les concentrations sériques de triglycérides (TG) et de HDL-cholestérol (HDL-c) ont été recueillies à partir du bilan lipidique de routine afin de calculer le ratio TG/HDL-c propre à chaque sujet.. Le bilan lipidique de routine a été dosé par méthode enzymatique sur l'automate ARCHITECT ci 8200(Abbott Diagnostics). Les patients ont ensuite été stratifiés en trois catégories de risque d'insulinorésistance selon les seuils prédéfinis de la littérature : un faible risque pour un ratio inférieur à 2, un risque modéré pour un ratio compris entre 2 et 3, et un risque élevé pour un ratio supérieur à 3.



Résultats

L'analyse quantitative de la cohorte (N = 98) a révélé un ratio TG/HDL-c moyen de $2,93 \pm 2,02$. La distribution des patients selon les seuils de risque d'insulinorésistance prédéfinis par la littérature met en évidence une prédominance des profils à risque métabolique accru :

- Risque élevé ($R > 3$) : 40% des sujets (n = 39), représentant la catégorie majoritaire de l'étude.
- Risque modéré ($R \in [2 - 3]$) : 23% des sujets (n = 23).
- Risque faible ($R < 2$) : 37% des sujets (n = 36)



Discussion

Nos résultats révèlent qu'une grande majorité de la population d'étude (63 %) se concentre dans la zone de risque métabolique modéré à élevé. Cette forte prévalence met en exergue l'omniprésence et la sévérité de la dyslipidémie athérogène — caractérisée par l'association d'une hypertriglycéridémie et d'une baisse du HDL-c — intimement liée au syndrome d'insulinorésistance chez le patient diabétique de type 2. L'élévation de ce biomarqueur chez près des deux tiers des sujets démontre sa haute pertinence clinique : il reflète fidèlement les perturbations lipidiques induites par le défaut d'action de l'insuline sur le tissu adipeux et hépatique

Conclusion

La forte proportion de profils perturbés observée dans notre série valide l'intérêt clinique du ratio TG/HDL-c. Simple, sans surcoût financier et immédiatement disponible à partir du bilan lipidique de routine, ce ratio s'impose comme un excellent outil de dépistage de masse et d'orientation rapide. Son adoption en pratique courante permettrait de repérer précocement les patients à forte probabilité d'insulinorésistance sévère, rationalisant ainsi la prescription de tests de confirmation plus onéreux et optimisant la prise en charge thérapeutique personnalisée